

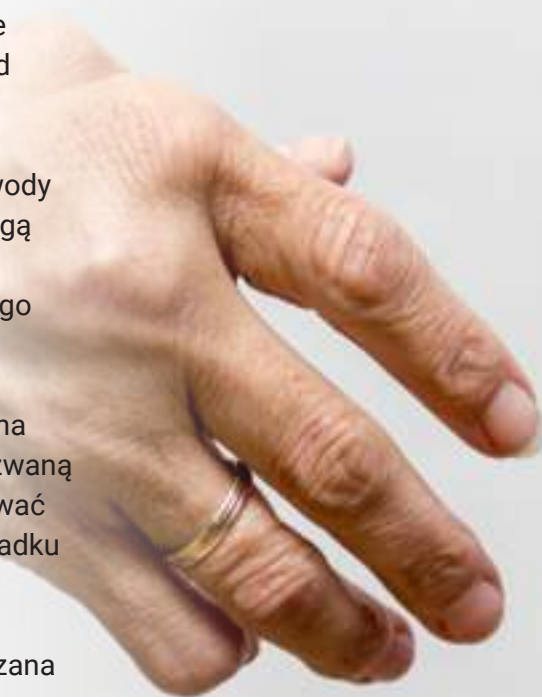


REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW

Reumatoidalne zapalenie stawów, czyli RZS, jest drugą najczęstszą chorobą po chorobie zwyrodnieniowej stawów

RZS to choroba autoimmunologiczna powodująca zapalenie stawów. Choroba autoimmunologiczna występuje, gdy układ odpornościowy organizmu wytwarza odpowiedź przeciwko tkankom lub substancjom naturalnie występującym w organizmie. Nie wiadomo, co wywołuje RZS, ale istnieją dowody sugerujące, że pewne czynniki związane ze stylem życia mogą zwiększać prawdopodobieństwo jej wystąpienia, takie jak palenie, wysokie spożycie kofeiny i duże spożycie czerwonego mięsa. Istnieje również składnik genetyczny na prawdopodobieństwo wystąpienia RZS.

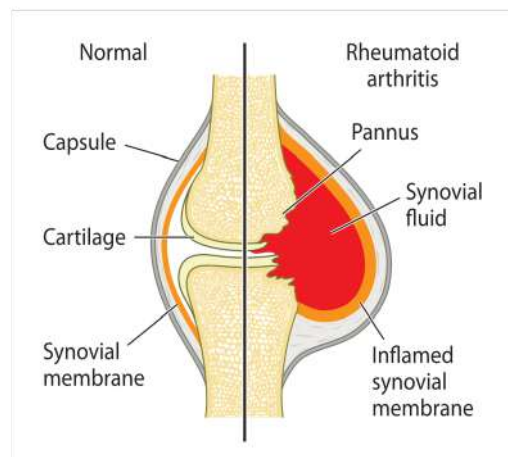
Staw to miejsce, w którym spotykają się dwie kości. Otoczona błoną maziową, która ma pogrubioną warstwę zewnętrzną zwaną torebką, struktura ta pomaga utrzymać staw razem i smarować powierzchnie, aby umożliwić płynny, ślizgowy ruch. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów błona maziowa jest atakowana przez układ odpornościowy. Staje się zapalona, zaczerwieniona i bolesna. Może wystąpić utrata ruchu związana z tym stanem zapalnym, wraz z ciepłem.



Osoby z RZS będą cierpieć na zaostrzenia, podczas których stan przechodzi przez epizody podrażnienia, po których następuje okres ulgi. W miarę jak stan zapalny ustępuje, torebka staje się workowata i nie podtrzymuje, ponieważ została rozciągnięta w okresie podrażnienia. W rezultacie staw staje się osłabiony, co predysponuje go do większego bólu i niestabilności. Chrzątka pokrywająca końce kości może się zużywać i rozwijać deformacje z powodu tej niestabilności.

Diagnozę stawia się na podstawie badania obrazowego, badań krwi i badania fizykalnego.

Charakter tej choroby sprawia, że osoby chorej nie można wyleczyć, ale leki i inne metody leczenia są bardzo skuteczne w łagodzeniu objawów, do których należą także letarg, anemia, depresja, stany zapalne innych części ciała i guzki reumatoidalne.



Chociaż może dotyczyć każdego stawu, reumatoidalne zapalenie stawów zwykle zaczyna się od dyskomfortu i sztywności w jednym obszarze, takim jak dłonie lub stopy. Obrzęk ma tendencję do rozpoczynania się wraz z towarzyszącym zaczerwienieniem i gorączką. Rokowanie jest różne, ale większość chorych będzie nadal miała sporadyczne łagodne epizody zaostrzeń. U mniejszości rozwinie się cięższa postać choroby ze znaczną chorobą i niepełnosprawnością.

Ponieważ osoby chore na reumatoidalne zapalenie stawów są narażone na inne powikłania związane z tą chorobą, takie jak zawał serca czy udar, ważne jest, aby ich stan był właściwie leczony.

Leczenie polega zazwyczaj na stosowaniu kombinacji leków, fizjoterapii, a w niektórych przypadkach zabiegu chirurgicznego.

Leki mogą obejmować środki przeciwbólowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w celu opanowania dyskomfortu i obrzęku. Pomagają one cierpiącemu z objawami, ale nie są ukierunkowane konkretnie na chorobę. Leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby (DMARD) są kluczem do kontrolowania samej choroby podczas zaostrzenia, ale ich działanie może zająć kilka tygodni. W takich przypadkach krótkoterminowe doustne sterydy lub nawet zastrzyki mogą być przydatne w oczekiwaniu na działanie DMARD.

Fizjoterapia koncentruje się na utrzymaniu zakresu ruchu stawów, aby zapobiegać ich sztywności, wzmacnianiu mięśni podtrzymujących stawy, aby przeciwdziałać niestabilności i ograniczyć zbędne zużycie, a także na dostarczaniu sprzętu łagodzącego dyskomfort stawów i/lub poprawiającego chód.

Ćwiczenia mogą obejmować zadania związane z utrzymaniem równowagi, mające na celu doskonalenie kontroli stawów za pomocą mięśni, ćwiczenia rozciągające, mające na celu utrzymanie zakresu ruchu stawów, oraz ćwiczenia wzmacniające, mające na celu poprawę wytrzymałości, siły i stabilności.

Ćwiczenia najlepiej wykonywać często i po trochu, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia stawów i zapobiec zmęczeniu. Znajdź sposoby na powiązanie rehabilitacji z codziennymi czynnościami, takimi jak mycie zębów, przygotowywanie napoju lub oglądanie reklam telewizyjnych.

W niektórych przypadkach chory korzysta z pomocy terapeuty zajęciowego w celu poprawy codziennego życia i funkcjonowania.



Większość chorych na RZS poradzi sobie z tymi konserwatywnymi metodami leczenia, ale niektórzy mogą potrzebować operacji. Może to być od drobnych zabiegów do poważnych, takich jak wymiana stawu. Operacja może być bardzo skuteczna w poprawie funkcji i niepełnosprawności u osób, które się jej poddają.